

1. Introducción y relevancia clínica

Los síndromes geriátricos **no corresponden a una enfermedad única**, sino a cuadros frecuentes en personas mayores que resultan de la interacción entre cambios fisiológicos del envejecimiento, comorbilidades, polifarmacia y factores ambientales. Entre los más prevalentes y relevantes se encuentran:

- **Incontinencia urinaria**
- **Constipación y fecalomas**
- **Úlceras por presión**

Todos ellos impactan de manera directa en:

- la **autonomía funcional**,
- la **calidad de vida**,
- el **riesgo de institucionalización**,
- y la **mortalidad**.

Además, generan **estigma, vergüenza, aislamiento social y sobrecarga del cuidador**, por lo que su manejo requiere un enfoque integral, interdisciplinario y centrado en la funcionalidad.

En el **EUNACOM**, estas condiciones suelen aparecer en:

- Casos clínicos de consulta ambulatoria,
- Manejo en hospitalizados,
- Prevención de complicaciones,
- Evaluación funcional.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

A) Cambios del envejecimiento relevantes

Con la edad, ocurren cambios fisiológicos que predisponen a estos síndromes:

Sistema	Cambios asociados al envejecimiento
Neuromuscular	Sarcopenia, pérdida de reflejos y coordinación
Genitourinario	Disminución capacidad vesical, aumento contracciones no inhibidas, disminución estrógenos en mujeres, hiperplasia prostática en hombres
Gastrointestinal	Disminución motilidad y sensibilidad rectal
Piel y microcirculación	Disminución elasticidad, presión capilar reducida → mayor riesgo de lesión por presión

Estos cambios **no son patológicos por sí mismos**, pero reducen la **reserva funcional**.

Cuando se agregan enfermedades crónicas, inmovilidad o polifarmacia → aparece el síndrome.

A) Incontinencia Urinaria

3. Clínica

Definición: Pérdida involuntaria de orina con repercusión higiénica o social.

Impacto clínico:

- Restricción de actividades,
- Depresión y ansiedad,
- Caídas (correr al baño),
- Dermatitis amoniacal.

Tipos principales:

Tipo	Descripción	Ejemplo
Urgencia	Deseo súbito e incontrolable	Vejiga hiperactiva
Esfuerzo	Pérdida con tos, risa, ejercicio	Debilidad piso pélvico (común en mujeres)
Mixta	Urgencia + esfuerzo	Muy frecuente en la práctica
Por rebosamiento	Goteo por vejiga sobredistendida	Hiperplasia prostática, obstrucción
Funcional	Dificultad para llegar al baño por causas físicas o cognitivas	Demencia, inmovilidad

Tipo	Descripción	Ejemplo

4. Evaluación diagnóstica

1. **Historia clínica detallada**
 - inicio, frecuencia, desencadenantes, nocturia.
2. **Revisión de medicamentos**
 - diuréticos, anticolinérgicos, sedantes, opioides.
3. **Examen físico**
 - Piel perineal, globo vesical, movilidad, evaluación cognitiva.
4. **Exámenes**
 - **EGO**, urocultivo si síntomas urinarios.
 - **Medición de residuo postmiccional** (ideal con ecografía).

No se inicia anticolinérgico sin medir residuo vesical.

5. Tratamiento (según MINSAL 2019)

Tipo	Tratamiento de primera línea
Urgencia	Ejercicios piso pélvico, entrenamiento vesical; si no responde → mirabegrón o antimuscarínicos
Esfuerzo	Kinesioterapia de piso pélvico (mínimo 6–12 semanas); cirugía se considera en casos seleccionados
Rebosamiento	Tratar causa obstructiva → si HPB: tamsulosina ± finasteride
Funcional	Adaptación ambiental (barandas, acceso a baño, horarios miccionales)

Puntos clave:

- Evitar oxibutinina en mayores polimedicados (riesgo de delirium).
- En mujeres posmenopáusicas con síntomas locales → **estrógeno tópico**, no sistémico.

B) Constipación y fecalomas

3. Clínica

Constipación: Menos de 3 deposiciones por semana, heces duras o esfuerzo excesivo.

En personas mayores, la constipación está asociada a:

- Bajo consumo de fibra o líquidos.
- Inmovilidad.
- Hipotiroidismo.
- Enfermedad de Parkinson.
- Opioides y anticolinérgicos.

Fecaloma: Impactación fecal dura en recto → puede producir **incontinencia paradójica**, dolor abdominal, confusión y delirium.

4. Evaluación diagnóstica

- Historia de hábitos intestinales
 - Palpación abdominal
 - **Tacto rectal**, esencial para confirmar fecaloma
 - Evaluar ingesta, hidratación, y movilidad
-

5. Tratamiento (MINSAL 2019)

Constipación

1. **Medidas generales:**
 - Aumentar fibra dietaria progresivamente,
 - 1.5–2 litros/día si no contraindicado,
 - Actividad física diaria.
2. **Laxantes** (orden recomendado):
 - **Formadores de bolo:** psyllium
 - **Osmóticos:** polietilenglicol (preferido), lactulosa
 - **Estimulantes:** bisacodilo, senósidos → uso puntual

Fecaloma

- **Desimpactación rectal manual + enema.**
- Luego iniciar esquema de laxantes **crónico preventivo**.

Nunca usar opioides en constipación sin laxantes permanentes asociados.

C) Úlceras por presión

3. Clínica

Lesiones de piel y tejidos subyacentes por presión mantenida en prominencias óseas.

Las zonas más afectadas son:

- Sacro.
- Talones.
- Trocánteres.
- Maléolos.

Factores de riesgo:

- Inmovilidad.
- Inconsciencia o confusión.
- Incontinencia.
- Desnutrición.

4. Evaluación y clasificación

Se utiliza **escala de Braden** para riesgo.

Clasificación por estadios:

Estadio	Lesión
I	Eritema no blanqueable
II	Pérdida parcial de piel
III	Pérdida total con exposición tejido subcutáneo
IV	Hueso/tendón expuesto; riesgo de osteomielitis

5. Tratamiento

1. **Prevención (pilar fundamental)**
 - Cambios de posición **cada 2 horas**
 - Superficies antiescaras
 - Hidratación y nutrición proteica adecuada
2. **Control de humedad**
 - Manejo de incontinencia
 - Barreras cutáneas protectoras
3. **Cuidado de la herida**
 - Limpieza con solución salina,
 - Apósitos según estadio (espumas, hidrocoloides),
 - Evitar povidona yodada de rutina.

4. Dolor y cuidado del paciente y cuidador

6. Complicaciones y pronóstico

- Celulitis/abscesos
- Osteomielitis
- Sepsis
- Desnutrición
- Dependencia funcional
- Institucionalización

La evolución depende de **movilización + nutrición + cuidados enfermería**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas

- La **incontinencia funcional** mejora corrigiendo *barreras ambientales*, no con fármacos.
- **Tacto rectal** es obligatorio ante sospecha de constipación complicada.
- **Movilizar no empeora las úlceras**, es parte del tratamiento.
- Estrógeno **tópico**, nunca oral, en atrofia urogenital.

Errores frecuentes

- Indicar anticolinérgicos sin medir residuo postmiccional.
 - Tratar incontinencia nocturna con diuréticos en la tarde.
 - Restringir líquidos (empeora constipación e incontinencia).
 - Usar almohadas en talones sin suspender presión (no protegen).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Estos síndromes son **multifactoriales** y requieren un enfoque integral.
2. La clave es **evaluar función**, no solo diagnóstico.
3. Incontinencia se clasifica en **urgencia, esfuerzo, mixta, rebosamiento y funcional**.
4. Constipación y fecaloma se diagnostican y tratan con **tacto rectal + desimpactación**.
5. El manejo de úlceras por presión es **prevención + alivio de presión + nutrición**.
6. La rehabilitación y el entrenamiento del paciente son **más importantes que el fármaco**.

7. Evitar medicamentos que empeoren condición (anticolinérgicos, sedantes, opioides sin laxantes).
-